

	IMPRESIÓN DE HISTORIA CLÍNICA PSICOLOGÍA	
	Historia # 00006	Fecha De Impresión: 08-07-2025 00:28:59

Datos Personales							
Nombre:	SARA MARIANA GUERRA MARTINEZ	Sexo Biológ.:	M	F. Nacimiento:	2006-09-12	Edad	18 Años, 9 Meses, Y 26 Días
Identificación:	CC - 1065598114	Lateralidad:		Estado Civil:	Soltero	Ocupación:	
Correo Electrónico:	Memafla@hotmail.Com - 1065598114			Dirección:	CALLE 11 # 23-46		
Departamento:	CESAR	Municipio:	VALLEDUPAR		Zona:	Urbana	
Empresa:	Particular						
En Caso De Emergencia Llamar A:		ROSA MARTINEZ - Parentesco (madre) - Teléfono (315 7220915)					

Apertura psicología del 2025-07-04 07:34:26: 18 años, 9 meses, y 26 días

DATOS GENERALES
Remisión Particular
DX principal NREF - NO REFIERE
Código de consulta 890208 - CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR PSICOLOGIA
Motivo de Consulta Acude a consulta por preocupación relacionada con pérdida significativa de peso (24 kilogramos en aproximadamente ocho meses), conductas alimentarias restrictivas y síntomas de ansiedad asociados a la ingesta de ciertos alimentos.
Enfermedad Actual Acude debido a la presentacion de sintomatologia caracteriada por dieta estricta a partir de noviembre de 2024, la cual ha mantenido hasta la fecha. Refiere haber pasado de un peso de 84 kg a 60 kg, manifestando una pérdida de 24 kg en pocos meses. Los sintomas se han agudizado a partir del año 2025, continúa con una preocupación constante por el contenido calórico de los alimentos, presenta una relación disfuncional con la comida y expresa miedo intenso a engordar. Literalmente señala: “cuando veo aceite, dulces me da fobia”, “me siento mal cuando como más de lo que tengo programado” y “cuento las calorías de todo lo que consumo”. Reconoce no tener una relación saludable con la alimentación y mantiene restricciones alimentarias rígidas. La madre refiere que el sábado anterior la paciente presentó un episodio de ansiedad significativo al percibir que “todo tenía grasa”, incluyendo utensilios como la freidora y el caldero. Comenta también que la pérdida de peso ha sido “exagerada”, que la paciente ha tenido una fuerte retracción física visible, pasando de usar ropa con pinzas a requerir tallas cada vez más pequeñas. Actualmente, usa una talla notoriamente inferior a la habitual. Informa además que la paciente no presenta menstruación desde hace aproximadamente cuatro meses (amenorrea secundaria).

ANTECEDENTES	
Médicos Personales	
Quirúrgico No Refiere	Tóxicos No Refiere
Traumáticos Ninguno	Medicación NEUROLOGÍA (No Refiere) PSIQUIATRÍA (No Refiere) DERMATOLOGÍA (minoxidil Tabletas 1mg, Loción DH8 W SE+B, Frasco Gotero 12 Ml, Espironolactona 100 Mg Tableta).
Paraclínicos Laboratorios	Hospitalizaciones No Refire
Patología No Refiere	

ANTECEDENTES	
Médicos Familiares	
Depresión Hermano/a	Ansiedad No Refiere
Demencia No Refiere	Alcoholismo No Refiere
Drogadicción No Refiere	Discapacidad Intelectual Hermano/a
Patológicos Diabetes	Otros Síntomas De Anorexia En La Madre

Áreas de Ajuste y/o Desempeño

Historia educativa

Actualmente cursa estudios universitarios en el programa de Economía en la Universidad WIS, ubicada en Bucaramanga. Ha completado satisfactoriamente cuatro semestres, evidenciando un desempeño académico adecuado. Se describe como una estudiante responsable (Autoexigente), con buen nivel de organización y cumplimiento de sus deberes académicos. Refiere mantener relaciones interpersonales positivas con sus compañeros y docentes, sin reportar dificultades significativas en el entorno educativo.

Historia laboral

No refiere

Historia familiar

a paciente reside actualmente con su núcleo familiar conformado por su madre, la señora Rosa Martínez (55 años); su padre, el señor José Alfonso Guerra (63 años); y sus hermanos: Melisa Guerra (25 años), María José Guerra (23 años), Gunnewia Guerra (15 años) y José Guerra (13 años). Refiere una convivencia en proceso de fortalecimiento de los lazos afectivos, la construcción de acuerdos y la aceptación mutua con sus hermanos. La relación con sus padres se mantiene estable. Se reportan algunos conflictos entre hermanos, los cuales son intervenidos activamente por los padres con el objetivo de promover la comunicación y fortalecer el vínculo familiar.

Historia social

La paciente manifiesta habilidades adecuadas para relacionarse con los demás en contextos donde ya existe un vínculo previo o cuando se siente en confianza. Sin embargo, presenta dificultades para integrarse en nuevos grupos o espacios sociales, especialmente cuando se enfrenta a situaciones sociales novedosas o numerosas. Prefiere mantener interacciones limitadas y seleccionadas, lo cual podría estar asociado a rasgos de inhibición social o inseguridad. No se evidencian comportamientos disruptivos ni conflictos interpersonales significativos, aunque su estilo social tiende a la reserva y selectividad en sus vínculos.

Historia socio-afectiva

La paciente se encuentra en un estado emocional de confusión y ambivalencia afectiva. Aunque refiere sentirse acompañada por su entorno cercano, manifiesta episodios de llanto frecuente (aproximadamente cada dos semanas) y presenta llanto fácil ante situaciones de frustración o sobrecarga emocional. Expresa sentimientos persistentes de soledad, acompañados de aislamiento social progresivo y una marcada dependencia afectiva hacia sus padres, lo cual limita su autonomía emocional. Se evidencian pensamientos rumiativos relacionados con su autoimagen, desempeño y relaciones interpersonales. Refiere baja autoestima, autorreferencias negativas frecuentes y una autocrítica excesiva. Además, presenta rasgos de perfeccionismo, que se manifiestan en exigencias elevadas hacia sí misma, dificultad para tolerar errores y malestar cuando no cumple sus propios estándares. Estas características afectan su bienestar emocional y su capacidad para afrontar de manera flexible las demandas cotidianas.

Interconsultas e Intervenciones

Intervención psiquiátrica

No refiere actualmente

Intervención neurológica

No refiere actualmente

Intervención neuropsicológica

No refiere actualmente

EXAMEN MENTAL

Examen Mental

La paciente ingresa a consulta en compañía de su madre, la señora Rosa Martínez. Se presenta con adecuado saludo y una presentación personal acorde al contexto clínico. Se encuentra orientada en las esferas alopsíquica y autopsíquica. Su apariencia general proyecta una imagen que impresiona mayor a su edad cronológica. Presenta facies triste, con rasgos de ansiedad, y evidencia compromiso somático vinculado a su estado emocional.

Mantiene contacto visual adecuado durante la entrevista. Su biotipo es leptosómico. Muestra actitud cooperativa, se encuentra alerta y receptiva. La memoria inmediata y remota impresiona conservada, al igual que la concentración. La atención es euproséxica. El lenguaje es eulálico, fluido y coherente. El pensamiento se presenta organizado (eupsiquia), sin presencia de alteraciones formales ni ideación delirante. No se reportan alucinaciones ni alteraciones sensorio-perceptivas.

El afecto se encuentra reactivo, con hipertimia orientada hacia el polo de la tristeza. La psicomotricidad es conservada, sin evidencias de agitación ni retardo. El juicio presenta distorsiones, especialmente en lo relacionado con la autoevaluación y la percepción corporal. La inteligencia impresiona dentro del promedio. Se encuentra consciente de su condición emocional, experimenta sufrimiento psíquico y manifiesta disposición voluntaria para iniciar tratamiento.

Ciclos del Sueño

Conservados

Apetito

Alterado

Actividades de Autocuidado

Independiente

IMPRESIÓN DIAGNOSTICA

Impresión Diagnóstica (CIE 10 - DSM-V):
F500 - ANOREXIA NERVIOSA

Establecido por primera vez

Si

PLAN DE INTERVENCIÓN

Plan de Intervención

Objetivo General

Promover la rehabilitación emocional y funcional de la paciente mediante el abordaje de los síntomas afectivos, conductas alimentarias disfuncionales, distorsiones cognitivas y dificultades en la regulación emocional, con el fin de mejorar su calidad de vida, autonomía y bienestar psicológico.

Objetivos Específicos

- **Identificar y psicoeducar sobre el trastorno de conducta alimentaria y sus implicaciones emocionales, cognitivas y físicas**, promoviendo la toma de conciencia sobre la problemática y favoreciendo una actitud colaborativa frente al tratamiento.
- **Disminuir las conductas restrictivas, perfeccionistas y obsesivas relacionadas con la alimentación**, a través de estrategias cognitivas y conductuales que favorezcan una relación más flexible y saludable con la comida.
- **Regular las emociones asociadas a la ansiedad, tristeza, miedo a engordar y sentimientos de soledad**, mediante técnicas de regulación emocional, mindfulness, reestructuración cognitiva o aceptación.
- **Fortalecer la autoestima, la autoimagen corporal y la autovaloración realista**, promoviendo una narrativa más compasiva y respetuosa hacia sí misma.
- **Fomentar la autonomía emocional y disminuir la dependencia afectiva hacia los padres**, facilitando el desarrollo de habilidades para la toma de decisiones, autoeficacia y manejo del malestar sin necesidad de validación externa constante.
- **Mejorar las habilidades sociales y la integración interpersonal**, abordando el aislamiento social progresivo y promoviendo vínculos saludables en diferentes contextos (familiares, educativos, sociales).
- **Favorecer la reestructuración del juicio clínico alterado**, especialmente en lo relacionado con la percepción corporal, el rendimiento personal y el sistema de creencias disfuncionales sobre el control, el peso y el valor personal.

Sugerencias e Interconsultas

- Remisión prioritaria por Psiquiatría
- Remisión prioritaria por Nutricionista
- Remisión por Ginecología

Observaciones y Recomendaciones

- Continuar con las terapias por Psicología clínica individual (2 veces por semana durante 3 meses)
- Continuar con las sesiones Psicoeducativas con la familia
- Iniciar y continuar con supervisión el plan nutricional orientado por el profesional en nutrición.
- Mantener un entorno familiar comunicativo y empático, supervisando con amor sin invadir su privacidad.
- Buscar espacios familiares de reconexión emocional.
- Hacer ejercicio físico guiado por un profesional en el deporte (Tendiendo en cuenta la opinión profesional por Psiquiatría y Nutricionista).



PRASCA
CENTER

DRA. MARIA ISABEL PUMAREJO

Psicóloga clínica
Tarjeta Profesional: 259542
Mag. TP3G - VIU